BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 9151 /QLD-ĐK
V/v thay đổi mẫu nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Vắcxin và Sinh phẩm số 1.
Số 1 – Yersin – Hà Nội - Việt Nam

Ngày 04/5/2018, Cục Quản lý Dược nhận được công văn số 92/CV-VABIOTECH đề ngày 24/4/2018 và các tài liệu có liên quan của công ty (số tiếp nhận 184/VXSP) bổ sung theo yêu cầu tại công văn số 6785/QLD-ĐK ngày 16/4/2018 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi mẫu nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng đối với thuốc đã được cấp số đăng ký lưu hành.

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc; Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BYT ngày 08/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc ghi nhãn thuốc;

Căn cứ Biên bản thẩm định hồ sơ thay đổi/bổ sung của công ty, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Đồng ý để công ty được thay đổi mẫu nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng đối với thuốc Varicella vaccine-GCC inj, số đăng ký: QLVX-1046-17.

Mẫu nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng thay đổi được đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược kèm theo công văn này.

Ngoài nội dung được thay đổi trên, tất cả các nội dung khác giữ nguyên như hồ sơ đăng ký thuốc lưu tại Cục Quản lý Dược.

Công ty đăng ký, nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm về chất lượng đối với thuốc lưu hành trên thị trường và có trách nhiệm thông báo sự thay đổi này đến các cơ quan liên quan và khách hàng.

Sau 06 tháng kể từ ngày ký công văn này, công ty không được nhập khẩu thuốc trên với các nội dung đã nghề nghị thay đổi.

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện đúng các quy định của Việt Nam về lưu hành thuốc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện KĐQG VX&SPYT (để p/h);
- Lưu: VT, ĐK (L).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

건 명	수두백신(VZV) 0.7mL 1vial 지함(베트남)		
규 격 (가로x세로x높이)	40x25x55mm	Q A	화순(해사팀)
		표시문안	4pt
색 상	4도 (별색3도 포함)	후 가 공	
제 작 일	2017.11.09.	작 업 처	(주)트리스톤

K

칼선 PANTONE 185C

※인쇄진행시, 인쇄사양과 다를경우
녹십자로 즉시 연락주시기 바랍니다.

PANTONE 357C

PANTONE 287C

PANTONE 348C

M.S.D.N: 0101066021 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẮCXIN VÀ SINH PHẨM SỐ 1
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
TĐ/BS ngày 24 tháng 5 năm 2018
(theo công văn 9151.../QLD-ĐK)



M.S.D.N: 0101066021 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẮCXIN VÀ SINH PHẨM SỐ 1
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

건 명	수두백신(VZV) 0.7mL 1vial 라벨(베트남)		
규 격 (가로x세로)	48x23mm	Q A	화순(해사팀)
		표시문안	3pt
색 상	4도 (별색3도 포함)	후 가 공	
제 작 일	2017.09.26.	작 업 처	(주)트리스톤

K

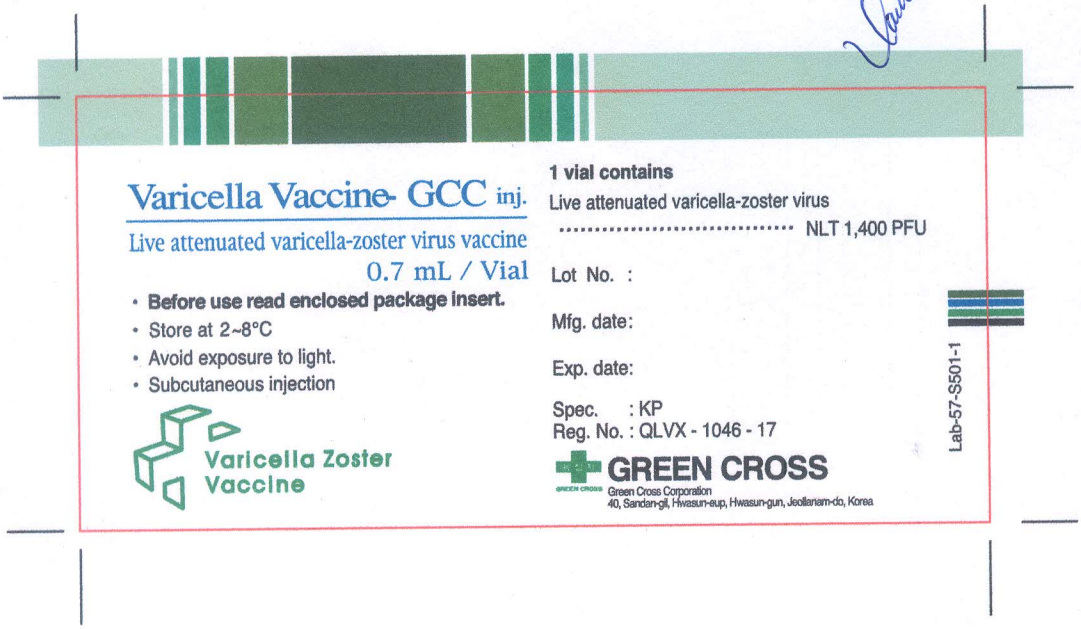
칼선 PANTONE 185C

※인쇄진행시, 인쇄사양과 다를경우 녹십자로 즉시 연락주시기 바랍니다.

PANTONE 357C

PANTONE 287C

PANTONE 348C



Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn

Vắc xin Varicella sống giảm độc lực

Varicella Vaccine-GCC inj.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Mô tả

Vắc xin là một chế phẩm đông khô của virut Thủy đậu (Varicella) sống giảm độc lực và tạo thành một dung dịch trong suốt, không màu hoặc có màu vàng nhạt sau khi pha với nước hồi chỉnh.

Thành phần

Trong 1 lọ vắc xin (0,7ml sau khi pha) có chứa :

Virus Varicella sống giảm độc lực.....	≥ 1.400 PFU
Sucrose.....	25mg
Glycine.....	2,5mg
Sodium L-glutamate hydrate.....	0,55mg
Gelatin.....	12,5mg
L-Cysteine.....	0,25mg
Edetate Disodium.....	0,25mg
$Na_2HPO_4.12\ H_2O$.....	vđ
$NaH_2PO_4.2H_2O$.....	vđ
Lọ nước pha tiêm kèm theo.....	0,7ml

Dạng bào chế

Bột đông khô.

Chỉ định

Vắc xin được sử dụng để phòng bệnh Thủy đậu cho các đối tượng từ 12 tháng tuổi trở lên.

Vắc xin nên được tiêm cho các đối tượng chưa mắc bệnh Thủy đậu.

Liều dùng và cách dùng

Tiêm 0,5 ml vắc xin sau khi hoàn nguyên với nước hồi chỉnh đi kèm.

Tiêm dưới da. Nhìn chung, vị trí tiêm là ở phần trên xương cánh tay và cần sát trùng trước bằng cồn hoặc cồn iod. Tránh tiêm lặp lại ở cùng vị trí.

Chống chỉ định

Vắc xin không sử dụng cho các đối tượng như:

- Sốt hoặc suy dinh dưỡng
- Đối tượng có rối loạn tim mạch, thận hoặc gan, rối loạn máu, rối loạn phát triển, hoặc các rối loạn khác đang trong thời kỳ hoạt động, gia tăng hay cấp tính.
- Bệnh nhân lao thể hoạt động không được điều trị.
- Bệnh nhân có bệnh đường hô hấp hoặc những người bị nhiễm trùng có sốt cấp tính.
- Bệnh nhân ốm nặng.
- Tiền sử sốc phản vệ với vắc xin này.
- Tiền sử quá mẫn với bất cứ thành phần nào của vắc xin.
- Tiền sử quá mẫn với kanamycin và erythromycin.
- Tiền sử sốt, phát ban, dị ứng,vv trong vòng 2 ngày sau khi chủng ngừa.
- Tiền sử co giật trong vòng 1 năm trước khi chủng ngừa.
- Suy giảm miễn dịch tế bào (Có thể được chẩn đoán bằng số lượng tế bào lympho, thử nghiệm quá mẫn muộn trên da,vv).
- Bệnh nhân ung thư, ung thư hạch, ung thư máu, hoặc loạn tạo máu, ảnh hưởng đến tủy xương và hệ thống bạch huyết.
- Suy giảm miễn dịch mắc phải, tiên phát bao gồm ức chế miễn dịch, suy giảm miễn dịch tế bào, giảm globulin máu, rối loạn globulin máu, kết hợp với AIDS hoặc biểu hiện lâm sàng của nhiễm virut suy giảm miễn dịch người.
- Bệnh nhân có tiền sử gia đình suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc được di truyền (Không tiêm ngừa cho đến khi khả năng miễn dịch được chứng minh).
- Bệnh nhân dùng thuốc ức chế miễn dịch.
- Mang thai hoặc có khả năng mang thai.

- Sẵn sàng thụ thai trong vòng 2 tháng.
- Sử dụng các vắc xin sống khác (Vắc xin bại liệt uống, vắc xin sởi, vắc xin Rubella, vắc xin Quai bị và vắc xin BCG) trong vòng 1 tháng.
- Bệnh nhân chưa đủ các điều kiện để tiêm phòng.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

- Kiểm tra tình trạng đục bất thường, sự đổi màu, tiểu phân,vv trước khi sử dụng. Không sử dụng sản phẩm nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu nào trên đây.
- Người tiêm vắc xin hoặc người giám hộ phải được thông báo nghỉ ngơi cho đến trước ngày tiêm phòng. Giữ chỗ tiêm sạch sẽ trước và sau khi tiêm phòng. Tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức nếu xảy ra sốt cao, co giật,vv.
- Điều trị với liệu pháp phù hợp bằng epinephrine (1:1000) ngay khi phản ứng quá mẫn xảy ra.
- Vắc xin này có chứa gelatin. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiêm chủng vì có báo cáo rằng việc dùng gelatin có liên quan đến sốc, sốc phản vệ (phát ban, khó thở, phù nề xung quanh môi hoặc thanh quản,vv). Khuyến cáo theo dõi sau tiêm chủng.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

Cần thận trọng khi tiêm phòng vắc xin trong thời kỳ cho con bú do một số virut có thể được bài tiết vào sữa mẹ cho dù chưa rõ virut thủy đậu có được bài tiết hay không.

Ảnh hưởng thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Một số tác dụng đề cập trong phần "Tác dụng không mong muốn" có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ với các thuốc khác

- Không tiêm vắc xin ít nhất 5 tháng sau khi truyền máu hoặc huyết tương và các globulin miễn dịch hoặc sử dụng Varicella zoster miễn dịch (VZIG). Bệnh nhân bị bệnh Kawasaki hoặc ban xuất huyết giảm tiểu cầu tự phát (ITP) người đã sử dụng lượng lớn gamma globulin (200mg/kg), cần hoãn tiêm chủng sau hơn 6 tháng.

Vắc xin thủy đậu sẽ không có hiệu quả nếu dùng gamma globulin trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiêm chủng. Vì vậy, khuyến cáo tiêm lại vắc xin 3 tháng sau lần tiêm chủng đầu tiên.

- Sau/trong khi chủng ngừa. immunoglobulin kể cả VZIG không được dùng trong 2 tháng trừ khi lợi ích hơn tiêm vắc xin.
- Những bệnh nhân đã được tiêm phòng các loại vắc xin sống khác (vắc xin bại liệt, vắc xin rubella, vắc xin quai bị, vắc xin sốt vàng da, vắc xin BCG,vv), thường sử dụng vắc xin thủy đậu sau hơn 4 tuần tiêm vắc xin sống khác.
- Trong vòng 6 tuần sau khi tiêm vắc xin, không sử dung salicylate do hội chứng Reye đã được báo cáo sau khi sử dụng salicylate trong thời gian nhiễm bệnh thủy đậu.
- Tương kỵ : Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của vắc xin, không trộn lẫn vắc xin này với các vắc xin/thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn

- Ở người lớn khỏe mạnh và trẻ em, sốt và/hoặc phát ban có thể xảy ra 1~ 3 tuần sau khi chủng ngừa. Những dấu hiệu này là tạm thời và sẽ giảm trong vòng vài ngày. Sốc phản vệ (Phát ban, khó thở, phù nề xung quanh môi hoặc thanh quản, vv) hiếm khi xảy ra.
- Rất hiếm khi xảy ra phản ứng quá mẫn như phát ban, nổi mề đay, ban đỏ, ngứa, sốt, vv có thể xảy ra ngay sau khi tiêm phòng và kéo dài cho đến ngày hôm sau.
- Ban xuất huyết giảm tiểu cầu tự phát (ITP) có thể xảy ra trong những trường hợp hiếm với tỉ lệ 1/1 000 000. Thông thường, ban xuất huyết, xuất huyết, xuất huyết niêm mạc,vv có thể xuất hiện vài ngày cho đến 3 tuần sau khi chủng ngừa. Bệnh nhân nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có những bệnh này phát sinh.
- Ở bệnh nhân có nguy cơ cao, nốt sần và mụn nước kèm theo sốt nhẹ có thể xảy ra từ 14 đến 30 ngày sau khi tiêm ngừa. Xu hướng xảy ra ở khoảng 20% bệnh nhân ung thư máu bạch huyết cấp tính.
- Herpes Zoster có thể xảy ra ở bệnh nhân có nguy cơ cao, tuy nhiên tỷ lệ mắc và mức độ nghiêm trọng không nghiêm trọng hơn ở những bệnh nhân bị nhiễm tự nhiên.
- Các tác dụng phụ tại chỗ: Da bị đỏ, sưng và cứng khớp có thể xảy ra tại vị trí tiêm.
- Toàn thân: Sốc phản vệ có thể xảy ra.
- Hệ thần kinh: Viêm não , hội chứng Guillan-Barre, viêm tủy ngang, liệt dây thần kinh ngoại biên, mất điều hòa và sự nhạy cảm bất thường có thể xảy ra.
- Hệ hô hấp: Viêm họng có thể xảy ra.
- Da: Hội chứng Steven-Johnson, hồng ban đa dạng, hội chứng ban xuất huyết Henoch-schonlein, bội nhiễm trên da và mô mềm bao gồm chốc lở/viêm tế bào và Herpes -Zoster có thể xảy ra.

- Các tác dụng phụ được liệt kê dưới đây theo thứ tự từ thường gặp nhất đến ít được báo cáo nhất:

+ Trẻ em dưới 12 tuổi:

Rối loạn đường hô hấp trên, ho, quá mẫn/cáu kỉnh, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, tiêu chảy, chán ăn, nôn mửa, viêm tai, viêm da tã lót/viêm da, đau đầu, buồn chán, đau bụng, phát ban, buồn nôn, đau mắt, ớn lạnh, tăng u lympho, đau cơ, rối loạn hô hấp dưới, phản ứng dị ứng, cứng cổ, phát ban nhiệt, đau khớp, bệnh chàm/khô da/viêm da, táo bón, ngứa.

Có báo cáo ghi nhận có trường hợp viêm phổi và co giật do sốt tuy nhiên đánh giá cho thấy không có mối liên hệ nào là nguyên nhân do việc sử dụng vắc xin.

+ Trẻ em 13 tuổi và người lớn:

Rối loạn đường hô hấp trên, nhức đầu, mệt mỏi, ho, đau cơ, rối loạn giấc ngủ, buồn nôn, tiêu chảy, cứng cổ, nhạy cảm, cáu kỉnh, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, các bệnh về mắt, đau bụng, chán ăn, đau khớp, viêm tai, ngứa, nôn, phát ban, táo bón, rối loạn hô hấp dưới, phản ứng dị ứng, viêm da, Herpes miệng/viêm niêm mạc miệng.

Thông báo ngay cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn có thể xảy ra.

Quá liều

Không có dữ liệu về sử dụng quá liều, không dùng quá liều chỉ định.

Thông tin về dược lý lâm sàng

Mã ATC: J07BK01 & J07BK02.

Quy cách đóng gói

Hộp 1 lọ bột đông khô + 1 lọ nước pha tiêm 0,7ml.

Bảo quản

Bảo quản từ 2-8°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Nhà sản xuất

Green Cross Corporation

40 Sandan-gil, Hwansun-eup, Hwansun-gun, Jeollanam-do, Korea.